Prophylaxie antianémique et anémie chez les femmes enceintes atteintes de troubles hypertensifs au Burkina Faso: Etude hospitalière transversale

Franck Garanet

Franck GARANET[1*] , Diane BAMOGO[2] , Jérome Winbetouréfâ SOME[1], Adama OUATTARA[3], Augustin Nawidimbasba ZEBA[1]

[1]Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST)/ Institut de Recherche en Sciences de la Santé (IRSS)/Département Biomédical et Santé Publique, Ouagadougou, Burkina Faso.

[2]Institut Africain de Santé (IASP),Ouagadougou, Burkina Faso.

[3]Université Joseph Ki-Zerbo (UJKZ)/Unité de Formation et de Recherche en Sciences de la Santé (UFR/SDS), Ouagadougou, Burkina Faso

Plan

- Introduction
- Objectif
- Matériel et méthode(s)
- Résultats
- Conclusion

Introduction (1/3)

- **L'anémie** est un **problème** de santé publique mondial **important**, touchant 36 % des femmes enceintes dans le monde, selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
- Les troubles hypertensifs de la grossesse peuvent contribuer à l'anémie gestationnelle ou l'exacerber

Introduction (2/3)

- Co-morbidité **augmente** la mortalité maternelle et infantile
- **Issues périnatales défavorables** de la grossesse avec des difficultés de contrôle des chiffres tensionnels en perpartum
- Prophylaxie anti-anémique (FAF) +++, réduire l'anémie chez les femmes enceintes

Introduction (3/3)

- Dans cette comorbidité , quelle est la relation entre la prophylaxie antianémique et l'anémie?

Objectif

- Examiner l'association entre la prophylaxie antianémique et l'anémie chez les femmes atteintes de troubles hypertensifs de la grossesse

Matériel et méthode(s)

- Une étude transversale chez des femmes enceintes diagnostiquées avec des troubles hypertensifs au cours du troisième trimestre
- Dans 02 CHR (Dori et Kaya), dans un contexte de crise sécuritaire 2019 à 2022

Matériel et méthode(s)

- L'anémie : taux d'hémoglobine inférieur à 7 g/dl
- Les troubles hypertensifs = l'hypertension chronique ou préexistante, l'hypertension gestationnelle et la prééclampsie/éclampsie
- Une analyse de régression logistique multivariée ajusté a été effectuée pour examiner la relation entre la prophylaxie antianémique et l'anémie
- Variables d'ajustement (âge, type THG, Hyperglycemie, Prophylaxie anti Palu)

Résultats (1/2)

- Au total, 986 femmes ont participé à l'étude
- Age moyen de 25,3 ± 6,3 ans
- La prévalence de l'anémie sévère chez les femmes atteintes de troubles hypertensifs de la grossesse était de 6,19 %
- La proportion des femmes n'ayant pas reçu la prophylaxie anti anémique au cours de la grossesse était de 9,33%

Résultats (2/2)

- Dans l'analyse multivariée ajusté sur l'âge, le type de troubles hypertensifs, la prise de prophylaxie antipalustre, l'hyperglycémie,
- la relation entre la prophylaxie anti-palustre et
- l'anémie sévère n'était pas statistiquement significative :

(**ORa=1,07** , **$IC_{95\%}$[0 ,46-2,46])**

Conclusion

- L'anémie chez les femmes enceintes atteintes de troubles hypertensifs de la grossesse est multifactoriel
- En plus de la prophylaxie antianémique,
- Il faut **adjoindre** d'autres actions de prévention afin de réduire le fardeau de la comorbidité anémie et troubles hypertensifs
- Nutrition optimale +++

Merci pour votre attention